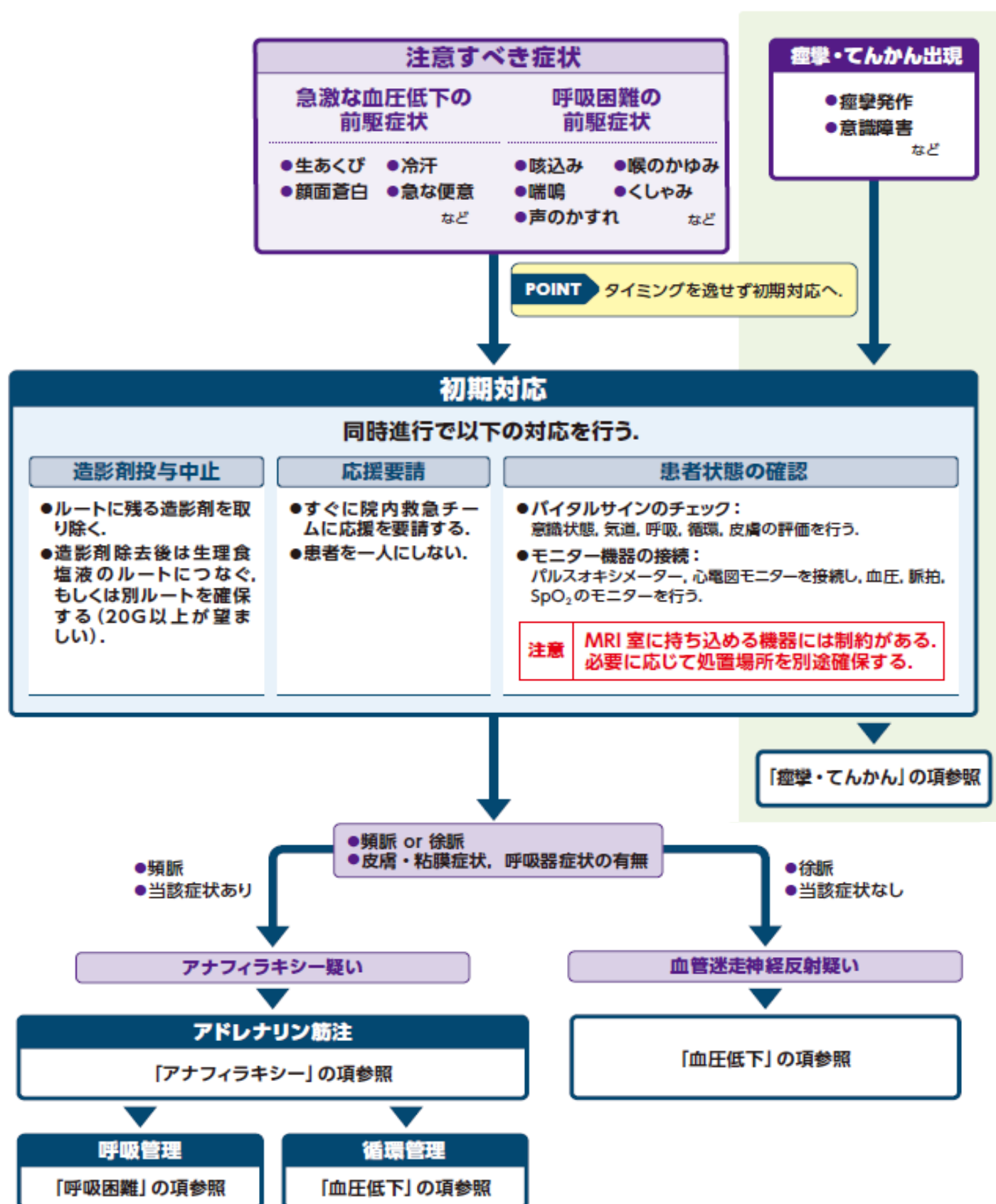
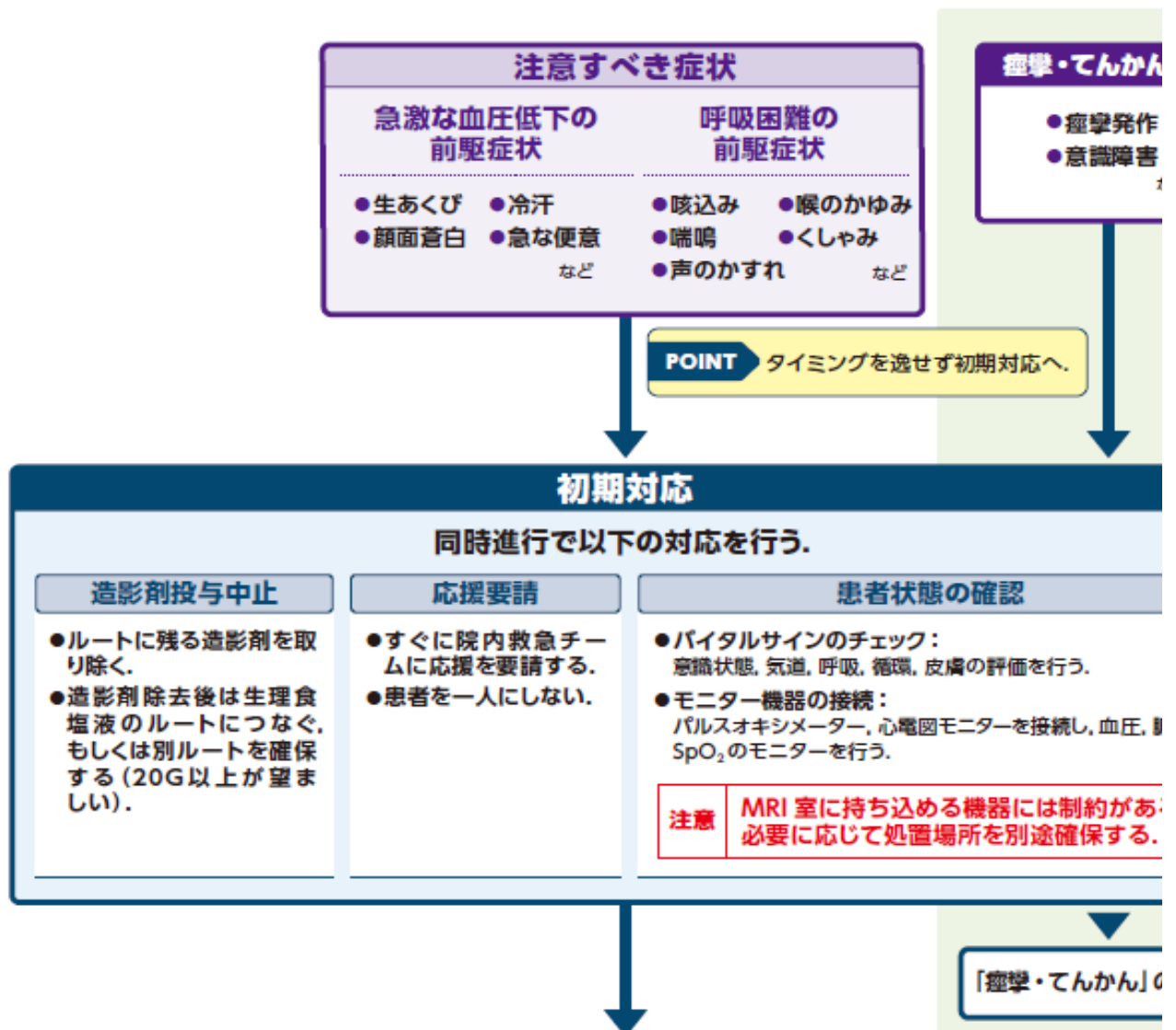






出現

など

脈拍。

る。

の項参照

造影剤使用時の
副作用発現時に
おける

初期対応

注意すべき症状

急激な血圧低下の 前駆症状

- 生あくび
- 顔面蒼白
- 冷汗
- 急な便意
など

呼吸困難の 前駆症状

- 咳込み
- 喘鳴
- 声のかすれ
- 喉のかゆみ
- くしゃみ
など

POINT

タイミングを逸せず初期対応へ。

痙攣・てんかん出現

- 痙攣発作
- 意識障害
など

初期対応

同時進行で以下の対応を行う。

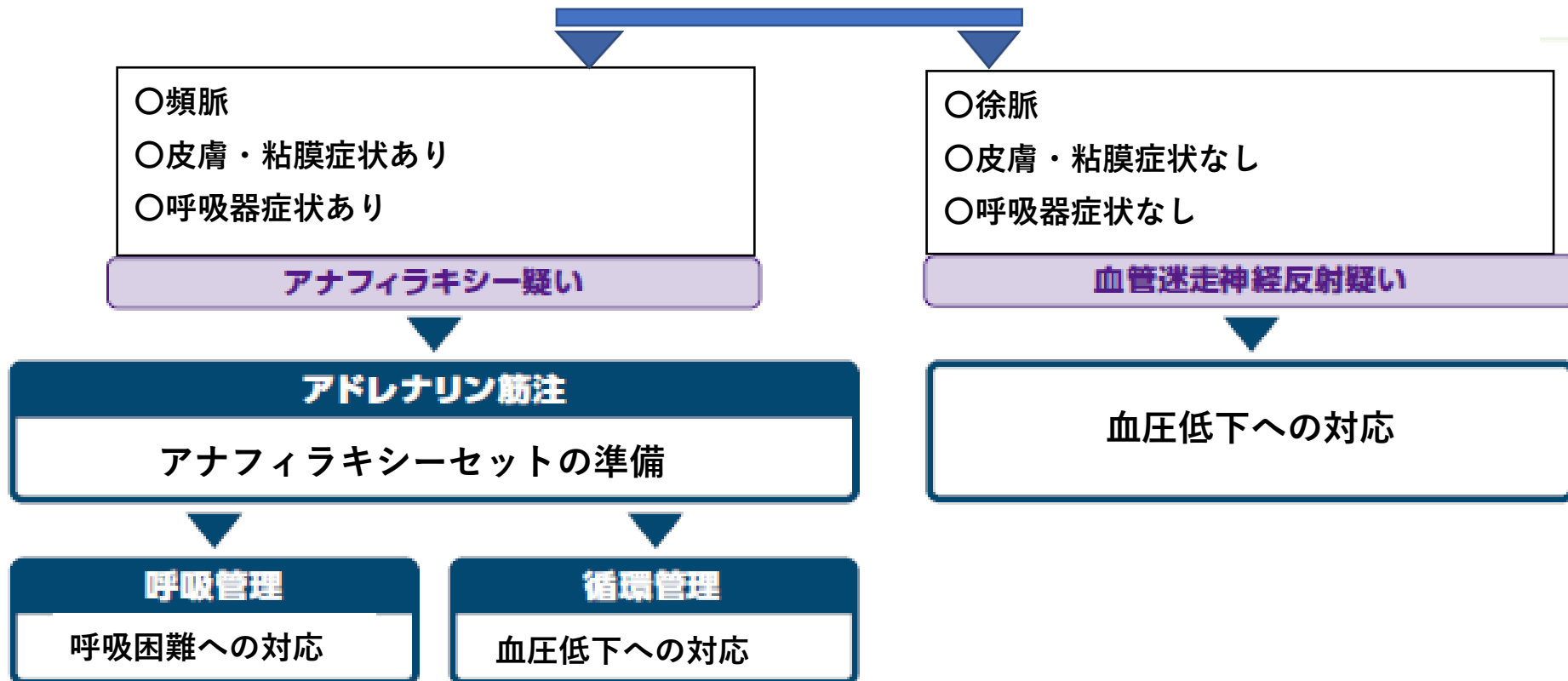
- 造影剤投与中止
- 輸液セットを留置針から外し、注射器で針の中の造影剤を吸引する。
- 造影剤を吸引したら、そこに生理食塩水のルートをつなぐか、あるいは別ルートを確保する。
(20G以上が望ましい)

- ハリーコール
- 患者を一人にしない

MRIの場合は、
患者をMRI室から出す

- バイタルサインのチェック（意識レベル 呼吸 血圧 脈拍 皮膚の状態の観察）
- パルスオキシメーター・モニターの装着

痙攣・てんかんへの対応



2023.6

長崎百合野病院 医療安全管理部
放射線科



造影剤使用時の
副作用発現時に
おける

初期対応

注意すべき症状

急激な血圧低下の 前駆症状

- 生あくび
- 冷汗
- 顔面蒼白
- 急な便意
など

呼吸困難の 前駆症状

- 咳込み
- 喉のかゆみ
- 喘鳴
- くしゃみ
- 声のかすれ
など

痙攣・てんかん出現

- 痙攣発作
- 意識障害
など

POINT

タイミングを逸せず初期対応へ。

初期対応

同時進行で以下の対応を行う。

- 造影剤投与中止
- 輸液セットを留置針から外し、注射器で針の中の造影剤を吸引する。吸引後は、そこに生理食塩水のルートをつなぐか、又は、別ルートを確保する。
(留置針は20G以上が望ましい)

①意識障害 ②呼吸困難
③ショック状態 のうち
いずれかある場合は

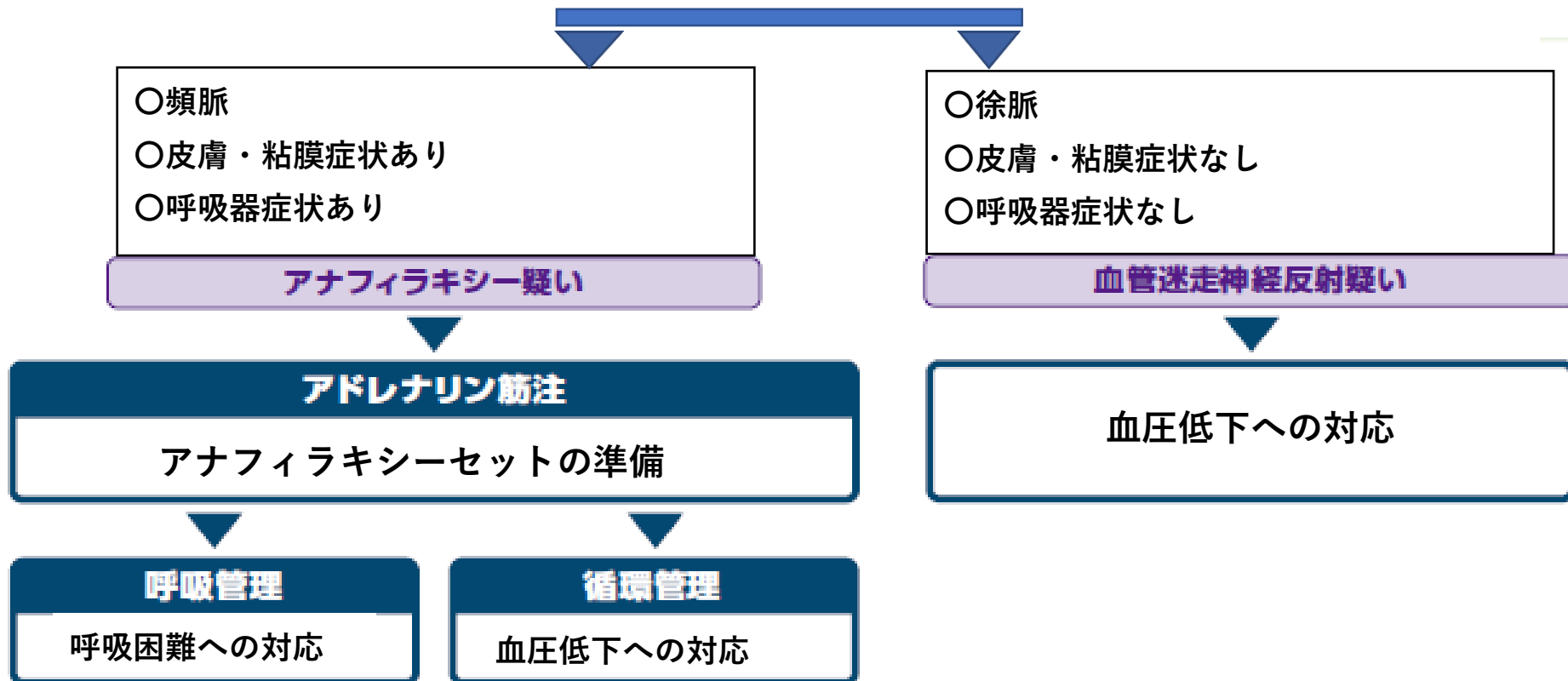
ハリーコール

①②③がない軽症の場合は、担当医コール

MRIの場合は、
患者をMRI室から出す

- バイタルサインのチェック（意識レベル 呼吸 血圧 脈拍 皮膚の状態等の観察）
- パルスオキシメーター、モニターの装着

痙攣・てんかんへの対応



2023.6

長崎百合野病院 医療安全管理部
放射線科



初期対応

